血液培養陽性感染性心内膜炎（IE）25 症例の検討　-微生物検査室と AST の役割-

◎高森 亮輔[1)]、重松 良実[1)]、宮寺 志保[1)]、中村 雅彦[1)]、町村 和世[1)]、松岡 百子[1)]
富山県立中央病院[1)]

[背景]感染性心内膜炎（IE）は高い死亡率を伴う重篤な感染症で、早期診断および適切な抗菌薬治療が重要である。血液培養を中心とした微生物検査室からの迅速報告と AST（Antimicrobial Stewardship Team）による抗菌薬適正使用支援は IE 診療において重要と考えられる。今回、血液培養陽性 IE 症例を対象に微生物検査室と AST の役割について、プロセス評価を含めて検討した。

[方法]2022 年 7 月～2025 年 12 月までに当院で経験した血液培養陽性 IE 25 例を後方視的に解析した。患者背景、起因菌、血液培養陽性時の微生物検査室対応、AST 介入率、血液培養複数セット採取率、適正抗菌薬選択率、de-escalation 実施率、心エコー実施率、手術実施率、AST 介入回数、転帰等を調査した。

[結果]年齢分布は 24 歳から 95 歳、平均は 72.2±16.2 歳、中央値は 76 歳、8 割が男性であった。65 歳以上の患者が 7 割を占めていた。血液培養からの検出菌は、レンサ球菌群（41%）、腸球菌（22%）、MSSA（19%）、CNS（18%）であった。血液培養陽性時の微生物検査室からのグラム染色結果報告は全例で 24 時間以内であった。AST 介入率は 84%であった。血液培養複数セット採取率は 100%、適正抗菌薬選択率は 100%、de-escalation 実施率は 72%であった。心エコー実施率 100%、手術実施率 56%であった。AST 介入回数は、平均 3.4±2.7 回、中央値 3 回であった。転帰は、回復退院が 84%、死亡が 16%であった。

[考察] 血液培養は感染性心内膜炎診断の要であり、当院では全例で複数セット採取が行われ、血液培養陽性時には微生物検査室から速やかにグラム染色結果が報告されていた。さらに AST が高率に介入し、適正抗菌薬選択や de-escalation につながっていたことから、微生物検査室と AST の連携は IE 診療における抗菌薬適正使用支援に有用であると考えられた。一方で、IE は重篤な合併症を伴う症例も多く、本検討では検査室・AST 介入と臨床転帰との直接的な関連は明らかにできなかった。今後は介入時期や介入内容の詳細な評価を行うとともに、症例数を増やして検討する必要がある。

連絡先：076-424-1531